今日論文 • 第 04 篇 公開全文

急性缺血性中風溶栓後早期針灸的療效與安全性：隨機對照試驗 Meta 分析

Early Acupuncture Following Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials on Efficacy and Safety

作者	Li G, Zhou Y, He Z, Li S, Bai Q, Fan S, Chen X, Yue M, Yang X, Shi J
期刊	Brain and Behavior（2026年11月；16卷11期，e71840）
識別碼	PMID 43002125 • DOI 10.1002/brb3.71840 • PMC13746989 • PROSPERO CRD420261358943
取用	公開全文（PMC）

官方連結（點擊即可打開）

- PMC 全文 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13746989/
- PubMed 摘要 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/43002125/
- DOI https://doi.org/10.1002/brb3.71840

研究是什麼

系統回顧與 Meta 分析，評估急性缺血性中風患者在靜脈溶栓後早期開始針灸，相對於溶栓加常規治療，對神經功能、日常生活活動能力及安全性的影響。

方法要點

- 檢索資料庫及試驗註冊，由建庫至 2026 年 3 月 31 日。
- 納入發病 14 日內、比較「溶栓＋針灸」與「溶栓＋常規溶栓後護理」的隨機對照試驗。
- 以均差或風險比及 95% 信賴區間進行統合；以 I^2 評估異質性，並預先設定亞組分析。
- 共納入 10 項試驗、1,116 名患者。納入研究以 RoB 2 評估，整體均被判斷為「部分關注」。

主要結果

- 輔助針灸使美國國立衛生研究院卒中量表（NIHSS）多下降 2.90 分（95% CI −3.62 至 −2.17），Barthel 指數多上升 12.07 分（95% CI 8.10 至 16.03），臨床反應率風險比 1.16（95% CI 1.11 至 1.21；均 P<0.001）。
- 不良事件組間無顯著差異（風險比 0.52，95% CI 0.25 至 1.08）。僅 1 項研究報告症狀性顱內出血（針灸組 0 例，對照組 6 例）。
- 作者指出，多數試驗未系統監測症狀性顱內出血。GRADE：NIHSS 證據確定性為低，Barthel 指數為極低，臨床反應率為中等，不良事件為低。
- 作者認為結果支持進一步以更嚴謹、有充分安全監測的隨機試驗評估溶栓後早期針灸。

中醫診所臨床啟示

- 急性中風溶栓屬醫院處理，社區中醫診所不宜自行介入超早期治療。

- 本稿只可作為康復階段與神經科協調針灸輔助的背景資料，不能外推至未接受溶栓，或發病超過本分析時窗的患者。
- 不能把「不良事件無顯著差異」解讀為已證明不增加出血風險，因為大多數試驗缺乏系統性出血監測。

限制與解讀注意

- 納入研究整體偏倚為「部分關注」，NIHSS 與 Barthel 指數異質性高、證據確定性偏低。
- 症狀性顱內出血的系統監測不足，安全性結論不完整。
- 試驗多在特定臨床路徑下進行，與本港急症及復康流程未必直接對應。

聲明：這份 PDF 由新聞bot 根據已核實的摘要及（如屬公開取用）論文頁面撰寫中文摘要，方便診所快速閱讀，並非出版社官方譯本，亦不是論文全文。關鍵數據請以官方全文為準。本摘要供專業參考，不能代替個別患者的臨床判斷。